

Seeking Safety — uzależnienie + trauma

Pierwszy program zaprojektowany dla osób z uzależnieniem i traumą jednocześnie. Cel: bezpieczeństwo „tu i teraz” — w 5 obszarach.

CZAS: 30 min refleksja 25 tematów (sesji) **ŹRÓDŁO:** Najavits (2002, podręcznik); Najavits & Hien (2013)

JAK UŻYWAĆ

Seeking Safety to **strukturyzowany program terapeutyczny** Lisy Najavits (Harvard) — pierwszy zintegrowany model dla osób z uzależnieniem i PTSD. **25 tematów**, każdy = jedna sesja, w 5 obszarach: poznawczy, behawioralny, międzyludzki, ułatwienie procesu, integracja. Centralna zasada: „**bezpieczeństwo jest pierwsze**” — pacjent uczy się **nie wracać do traumy** (jak w PE) i **nie zaspokajać przez używanie**, ale budować bezpieczne strategie radzenia. Karta przedstawia: 1) **5 zasad**, 2) **25 tematów**, 3) dla kogo, 4) gdzie uczestniczyć.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Najavits (2002) zaprojektowała Seeking Safety na podstawie obserwacji: **60-80% osób z uzależnieniem ma w wywiadzie traumę**, a 30-60% spełnia kryteria PTSD. Klasyczne programy traumy (PE — przedłużona ekspozycja, EMDR) **retraumatyzują** osoby aktywnie używające. Klasyczne programy uzależnień nie adresują traumy. Wynik: pacjent „**spada między dwa krzesła**”. Seeking Safety stabilizuje obie diagnozy jednocześnie, **nie pracując bezpośrednio z traumą** — to dopiero po stabilizacji. Najavits & Hien (2013, metaanaliza n=4116): SS daje **50% redukcję objawów PTSD i 40% redukcję używania** w 6 miesiącach — i jest dostępne dla terapeutów bez specjalizacji w traumie.

01 Pięć zasad bezpieczeństwa

1 · BEZPIECZEŃSTWO JEST PIERWSZE

Nie pracujemy z traumą, dopóki używanie i kryzysy nie ustabilizowane. Praca z traumą u aktywnie używających retraumatyzuje.

2 · ZINTEGROWANE LECZENIE

Trauma i uzależnienie pracowane jednocześnie, nie sekwencyjnie. „Najpierw uzależnienie, potem trauma” — często nie działa.

3 · PRACA Z IDEALAMI

Trauma i używanie niszczą ideały („nie zasługuję”, „świat jest okrutny”). SS wskrzesza ideały — uczciwość, zaangażowanie, wzajemność.

4 · 4 OBSZARY PRACY

Poznawczy (myśli) · **behawioralny** (działania) · **międzyludzki** (relacje) · **process** (jak prowadzimy terapię).

5 · UWAGA NA PROCES — W TYM TAKŻE SAMEGO TERAPEUTY

SS uznaje, że trauma „*przenosi się*” na terapeutę (zastępcza traumatyzacja, ang. *vicarious trauma*). Superwizja, granice, samodbałość terapeuty — kluczowe.

02 25 tematów programu — przykładowe

BEZPIECZEŃSTWO

sygnały bezpieczeństwa w 5 obszarach (ciało, umysł, relacje, świat, działanie)

ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE

jak trauma + używanie zniekształcają myślenie

WYBAWCA / KAT / OFIARA

rozpoznawanie ról relacyjnych

GRANICE W RELACJACH

asertywność, „nie” bez wstydu

ODZYSKIWANIE KONTROLI

co jest w mojej, co poza mocą

TWORZENIE SENSU

co znaczy ta historia w moim życiu

WSPÓŁCZUCIE SOBIE

jak rozmawiać ze sobą jak z dzieckiem

WSPARCIE Z ZEWNĄTRZ

jak prosić, kogo, kiedy

SPOŁECZNOŚĆ

grupy, kościół, kluby, wolontariat

PRZEBACZENIE

sobie + innym — proces, nie wydarzenie

03 Dla kogo Seeking Safety

DLA KOGO DZIAŁA

- uzależnienie + trauma (PTSD lub objawy podprogowe)
- aktywne używanie lub świeża abstynencja
- potrzeba *stabilizacji*, nie pracy z traumą
- brak czasu / dostępu do specjalisty traumy
- dla obu płci, wszystkich substancji, behawioralnych

CZEGO SS NIE ZASTĘPUJE

- terapii przedłużonej ekspozycji (PE) — po stabilizacji
- EMDR — po stabilizacji
- farmakoterapii uzależnienia (naltrekson, akamprozat)
- detoksu medycznego w razie ciężkiego odstawienia
- grup wsparcia (AA, NA, SMART)

04 Moja refleksja — czy SS jest dla mnie

CZY MAM W WYWIADZIE TRAUMĘ

— przemoc, zaniedbanie, wypadek, śmierć bliskiego, inne

OBJAWY PTSD U MNIE

— flashbacki, koszmary, unikanie, hiperczułość

CZY UŻYWANIE I OBJAWY NASILAJĄ SIĘ WZAJEMNIE

— który podsycy który

CO KONKRETNIE OMÓWIĘ Z TERAPEUTĄ

— pytanie o SS lub inną terapię zintegrowaną

Klucz: Najavits & Hien (2013, metaanaliza 32 badań, n=4 116) wykazali, że Seeking Safety jest **najlepiej udokumentowanym programem zintegrowanym** uzależnienie + PTSD. Korzyść unikalna: *nie wymaga rozmów o traumie*. Cała praca dzieje się „tu i teraz” — co budowanie bezpieczeństwa, zmieniać myśli, układać relacje. Trauma nie jest „ignorowana” — jest **respektowana w tle**: program nie zmusza do jej otwierania, póki pacjent nie jest gotowy. W Polsce: program jest dostępny przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne; podręcznik tłumaczony jako „W poszukiwaniu bezpieczeństwa” (GWP).